Árbol de decisión — Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Lumbar. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿El dolor CENTRALIZA con movimientos repetidos (Método McKenzie/MDT)? 📝 R9

- SÍ → 3 Dolor Radicular Lumbar
- NO → 3 Dolor Radicular Lumbar

1c ¿Hay déficit de fuerza, sensibilidad o reflejos en la pierna (comparado con el lado sano)? 📝 R5

- SÍ → 5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)
- NO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda? 📝 R1, R2, R4, R6

NO

2 ¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante? 📝 R6, R7, R8

todas

3 ¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante? 📝 G1, G3, G4

todas

4 ¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.)

📝 R3, R6, R9, R10, R11, R12

Respuestas

SÍ
SLR positivo <60° o Test de Slump positivo
→ → desvío 1b

NO
Sin irradiación predominante a la pierna
→ sin hipótesis

Respuestas

SÍ
Dolor bilateral en glúteos/muslos, alivio con "signo del carrito de compras"
→ 4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica

NO
Sin este patrón
→ sin hipótesis

VASCULAR
Los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie, sin sentarse ni flexionar: sospecha de claudicación vascular → derivación médica
→ **Derivación médica**
Sospecha de claudicación vascular (los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie): derivación médica para valorar la circulación de las piernas.

Respuestas

Agudo/Rigidez
Síntomas <16 días, sin dolor bajo la rodilla y restricción segmentaria hipomóvil
→ 1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)

Persistente/Inestabilidad
Dolor en rangos finales o posturas sostenidas con sensación de "fallo"
→ 2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)

Ninguno de los dos
Continuar con el patrón de dolor inespecífico
→ sin hipótesis

Respuestas

DISCOGÉNICO
Dolor en línea media + preferencia direccional o centralización con movimientos repetidos; puede cambiar de lado
→ 6 Dolor Lumbar Discogénico

FACETARIO
Paramedial unilateral, dolor en extensión o extensión + rotación, sin pasar de la rodilla; los repetidos no alivian
→ 7 Dolor Lumbar Facetario

SACROILÍACA
Dolor en zona de Fortin sin dolor en Tuber, no centraliza
→ 8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca

MIOFASCIAL
Banda tensa palpable + punto hipersensible + el paciente reconoce el dolor provocado
→ 9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar

NINGUNO
Sin patrón predominante
→ sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis
- 📝 Formulario del paciente (G general, R región)

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor lumbar inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de lumbar.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0